

Abdome Agudo Vascular e Obstrutivo

Professor (a):

Paula S. Mesquita

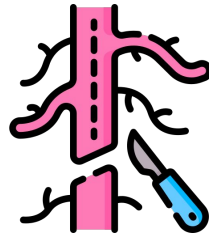
Intensivista pelo HCFMUSP

Diarista da UTI da Gastroenterologia do HCFMUSP



Abdome agudo vascular

Síndrome aguda abdominal relacionada ao comprometimento do fluxo sanguíneo do TGI (arterial ou venoso).



Abdome agudo
vascular

Embolia arterial

**Isquemia / Trombose
mesentérica (arterial ou
venosa)**

Não oclusiva



Abdome agudo
vascular

Embolia arterial

**Isquemia / Trombose
mesentérica (arterial ou
venosa)**

Não oclusiva

UTI

Isquemia mesentérica



Abdome agudo
vascular

Embolia arterial

**Isquemia / Trombose
mesentérica (arterial ou
venosa)**

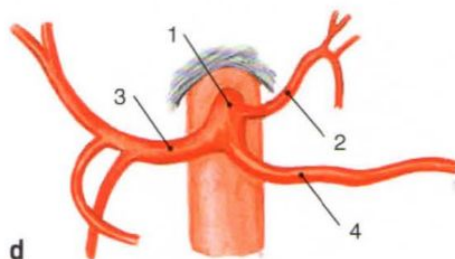
Não oclusiva

UTI

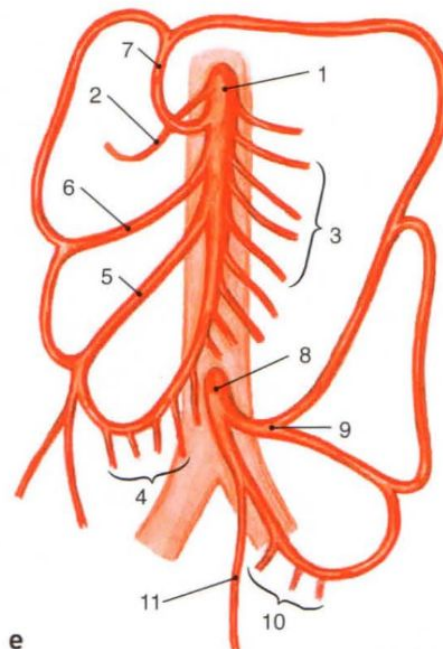
Paciente grave, distendido,
lactato alto ...



Isquemia mesentérica



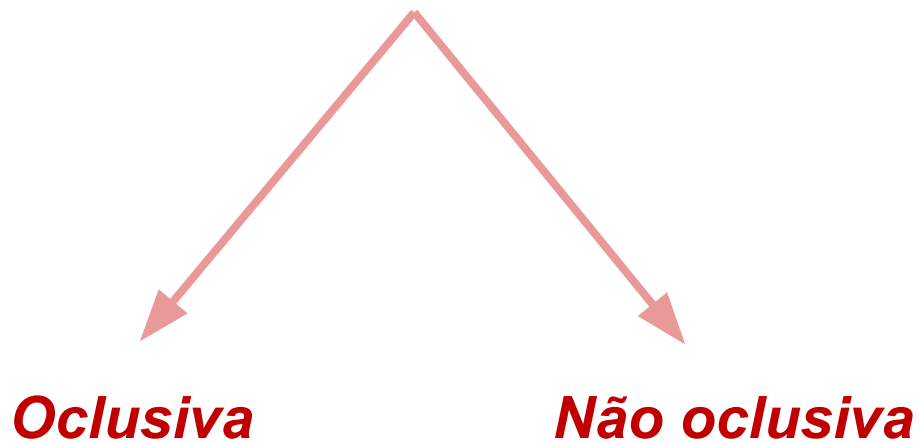
- d
- 1 Tronco celiaco
 - 2 A. gástrica esquerda
 - 3 A. hepática comum
 - 4 A. esplênica



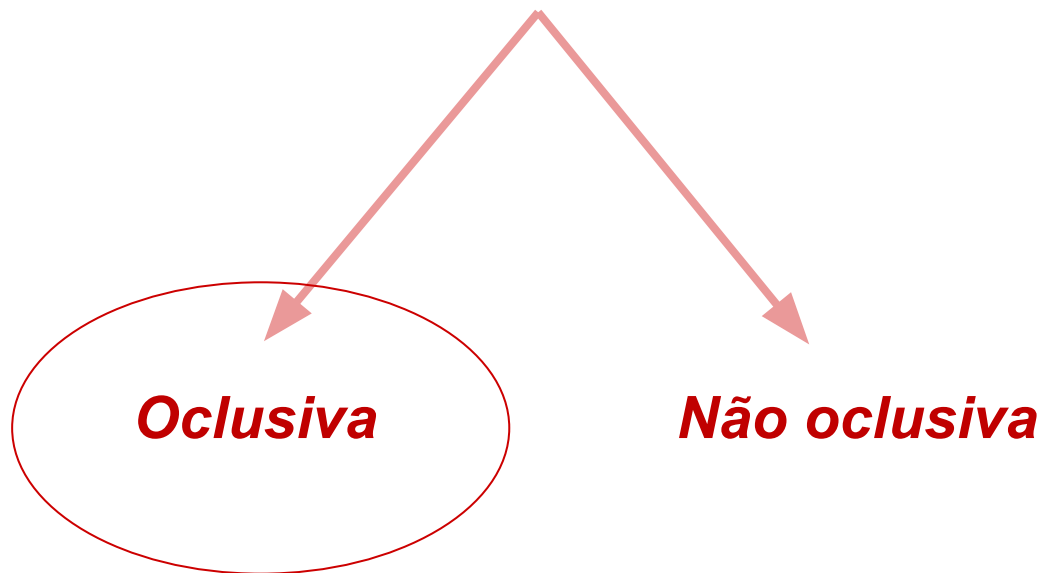
- e
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1 A. mesentérica superior | 6 A. cólica direita |
| 2 A. pancreático-duodenal inferior | 7 A. cólica média |
| 3 Aa. jejunais | 8 A. mesentérica inferior |
| 4 Aa. ileais | 9 A. cólica esquerda |
| 5 A. ileocólica | 10 Aa. sigmóideas |
| | 11 A. retal superior |



Isquemia mesentérica



Isquemia mesentérica



Isquemia mesentérica oclusiva

Relacionado com
Fibrilação Atrial

- Etiologia embólica, maioria cardiogênica;
- Artéria mesentérica superior em 40-50% dos casos;
- Pode estar associada à outras embolizações (baço, rim);

Quadro:

Dor abdominal desproporcional ao exame físico
+
Hiperlactatemia



Isquemia mesentérica oclusiva

- Etiologia embólica, maioria cardiogênica;
- Artéria mesentérica superior em 40-50% dos casos;
- Pode estar associada à outras embolizações (baço, rim);

Quadro:

Dor abdominal desproporcional ao exame físico

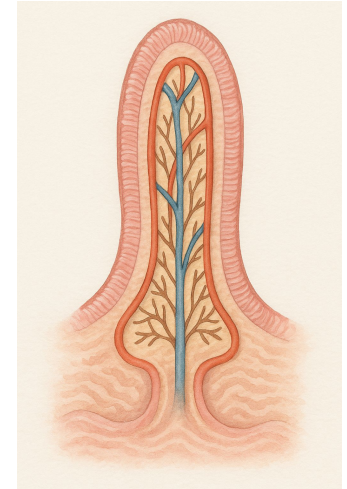
+

Hiperlactatemia



Hiperlactatemia

- O leito esplâncnico recebe ~25% do débito cardíaco (mucosa consome a maior parte)
- Em repouso, 65–75% do fluxo intestinal vai para a mucosa; em vasodilatação máxima, até 90%
- Vasoconstrição mesentérica ocorre em ~10 min após hipotensão



Systematic Review

The Efficiency of Serum Biomarkers in Predicting the Clinical Outcome of Patients with Mesenteric Ischemia during Follow-Up: A Systematic Review

- Hipoperfusão intestinal precoce → ↑ metabolismo anaeróbico → ↑ L-lactato
- Lesão mucosa + translocação bacteriana → ↑ D-lactato
- Ambos podem se elevar em até 5 minutos após início da isquemia.
- Gasometria atual não diferencia L- vs. D-lactato → necessidade de métodos específicos no futuro.

**O que a gente mede na prática clínica de rotina é o L-lactato, produzido pelas nossas células durante o metabolismo anaeróbico. Já o D-lactato é produzido principalmente por bactérias intestinais durante a fermentação de carboidratos.*



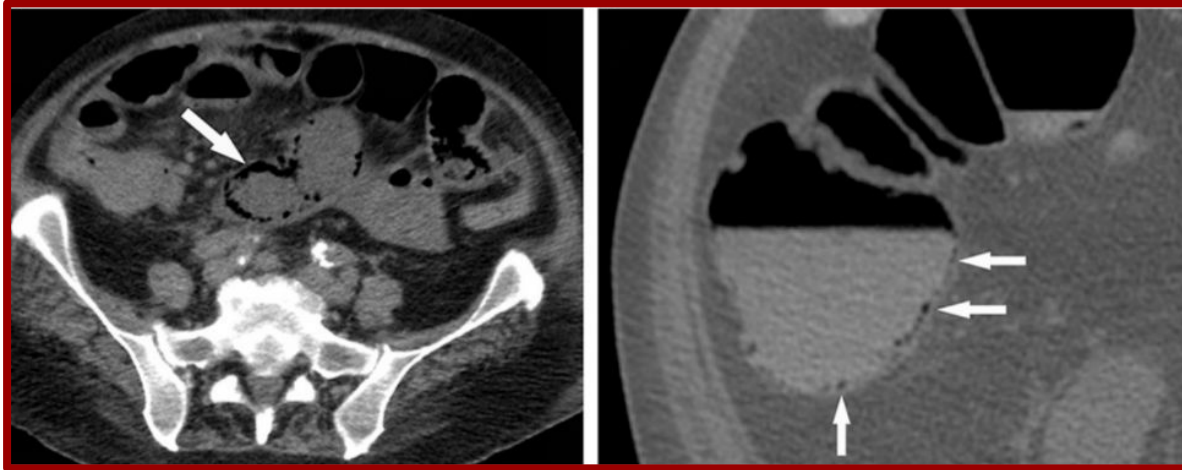
Isquemia mesentérica oclusiva



N Engl J Med 2016;374:959-968
DOI: 10.1056/NEJMra1503884



Isquemia mesentérica oclusiva



Yu H, Kirkpatrick IDC. *Assoc Radiol J.* 2023;74(1):160-171.
doi:10.1177/08465371221094280



Isquemia mesentérica NÃO oclusiva

- Redução difusa e sustentada do fluxo sanguíneo mesentérico, geralmente causada por hipoperfusão sistêmica e/ou vasoespasmo;
- Sem obstrução mecânica do vaso;

Quadro abdominal menos exuberante:

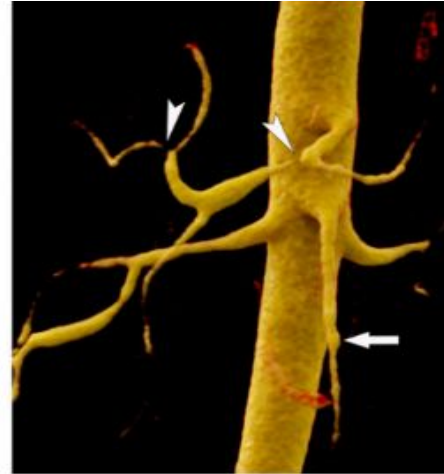
Maioria é DMOS + distensão !

*pode ter diarreia e sangramento do TGI



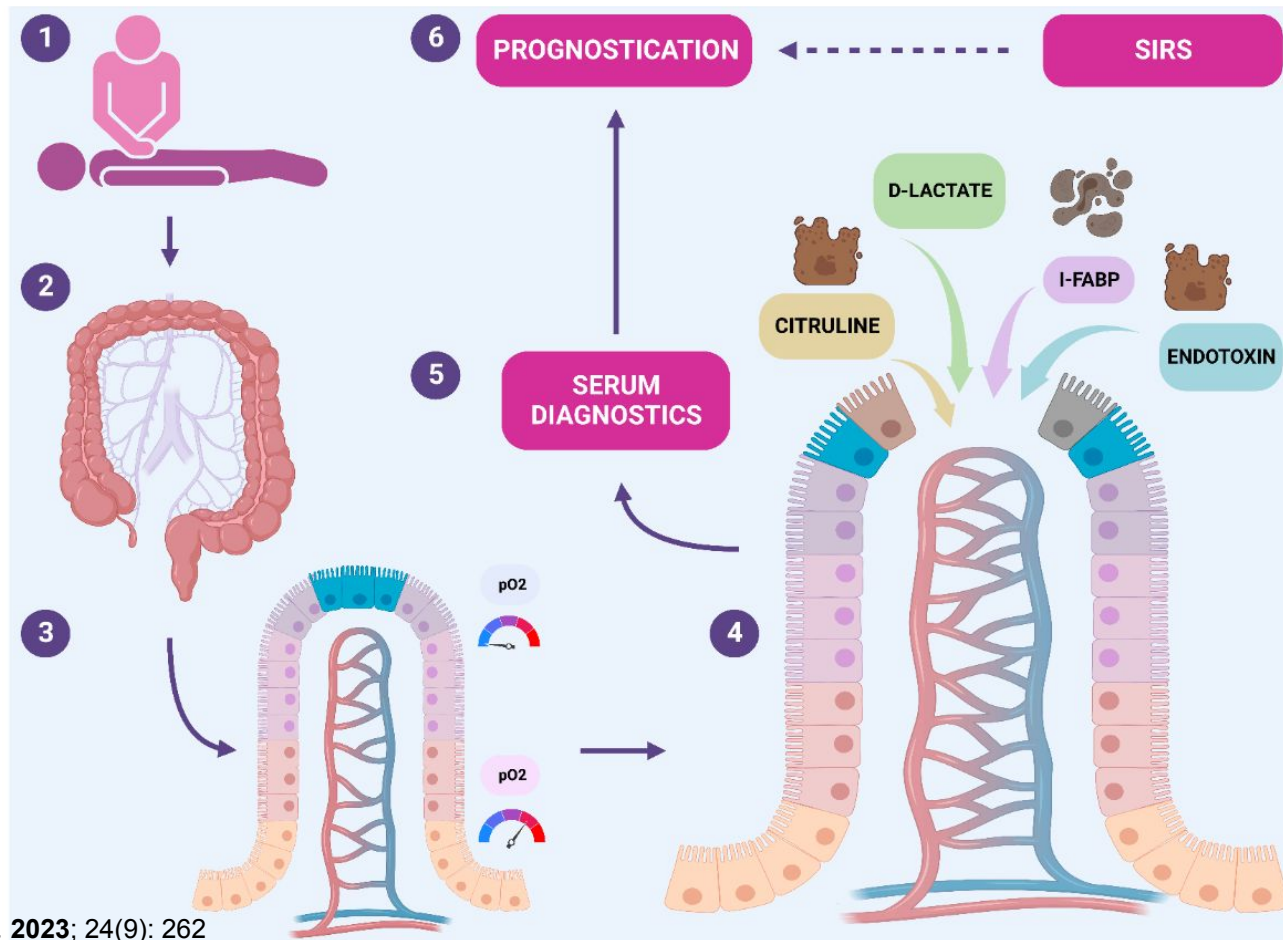
Isquemia mesentérica NÃO oclusiva

Choque, vasopressores, Pós PCR e pós operatório de cirurgias cardíacas;



Yu H, Kirkpatrick IDC. *Assoc Radiol J.* 2023;74(1):160-171.
doi:10.1177/08465371221094280





Anticoagulation management and outcomes in critically ill patients with acute mesenteric ischemia: an international study



Intensive Care Med (2025) 51:1087–1097
<https://doi.org/10.1007/s00134-025-07980-4>

Anticoagulação plena precoce (<48h) vs. não precoce.

Estudo observacional

Sobrevida em 30 dias:

- 53,5% com anticoagulação precoce vs. 41,7% sem ($p=0,01$).
- NNT = 8.

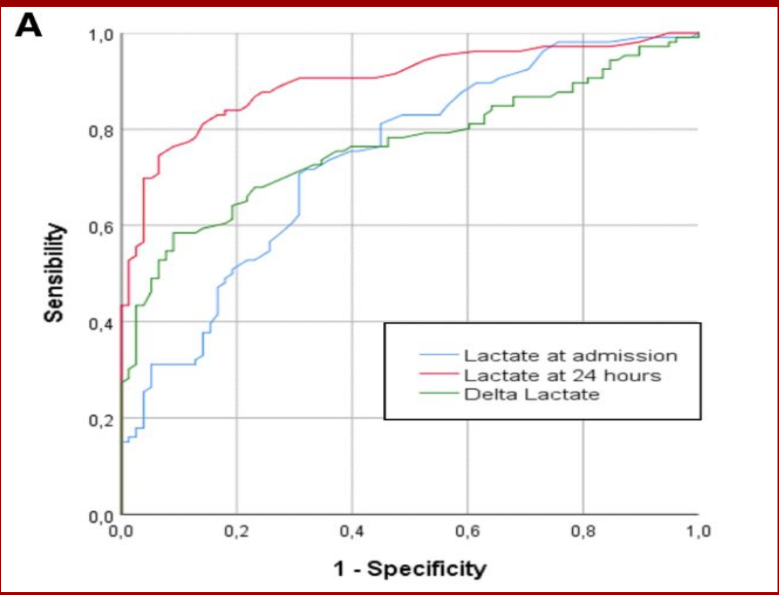
Subgrupo NOMI: **não mostrou benefício.**



Prognostic factors of acute mesenteric ischemia in ICU patients



Caluwaerts et al. *BMC Gastroenterology* (2019) 19:80
<https://doi.org/10.1186/s12876-019-0999-8>



Mortalidade elevada: 71% em 30 dias.

*maioria era NOMI

Maioria com DMOS no momento do diagnóstico.

Pior prognóstico :

- Dose máxima de vasopressores
- Aumento do lactato arterial em 24h



Tratamento

Isquemia mesentérica

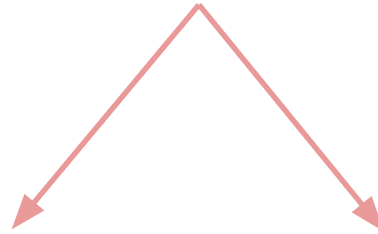
Oclusiva

Não oclusiva



Tratamento

Isquemia mesentérica



Oclusiva

Não oclusiva

Revascularização precoce:

- **Cirúrgica:** embolectomia, trombectomia, endarterectomia
- **Endovascular:** angioplastia, trombólise local ou tromboaspiração.

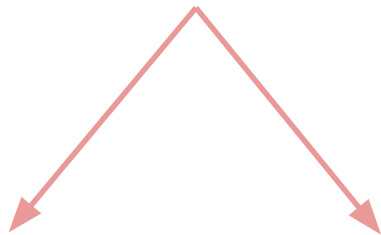
Ressecção intestinal: indicada quando há necrose estabelecida + “second look” em 48h

Anticoagulação plena: geralmente heparina IV sistêmica logo ao diagnóstico.



Tratamento

Isquemia mesentérica



Oclusiva

Não oclusiva

Otimizar débito cardíaco

- Reduzir/ajustar vasopressores (altas doses podem piorar).

Vasodilatadores intra-arteriais (investigacionais, em centros especializados):

- Papaverina, prostaglandinas, alprostadil → administrados por cateter arterial.

Anticoagulação plena: pode ser usada, mas evidências menos robustas

Cirurgia: somente quando há sinais de peritonite ou necrose intestinal irreversível.

Foco na UTI ...

- Avaliação da equipe cirúrgica = sempre na não oclusiva
- Anticoagulação plena = sempre na não oclusiva
- Otimizar hemodinâmica = sempre



Foco na UTI ...

- Avaliação da equipe cirúrgica = sempre na não oclusiva
- Anticoagulação plena = sempre na não oclusiva
- Otimizar hemodinâmica = sempre 
- Antibióticos

Sem grandes evidências, mas altamente recomendado pelos especialistas.

Ex.: Ceftriaxone + Metronidazol (4-7d)



Obrigada

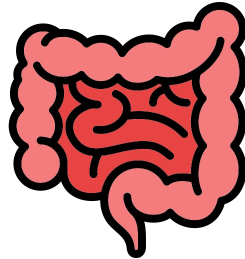
Dúvidas :

gastrointensiva@gmail.com



Abdome agudo obstrutivo (AAO)

Quadro clínico caracterizado pela interrupção parcial ou completa do trânsito intestinal, levando a distensão abdominal e risco de isquemia ou perfuração.



AAO
(delgado ou colon)

Aderências

Hérnias

Tumor

Volvo



AAO
(delgado ou colon)

Aderências

Hernias

Tumor

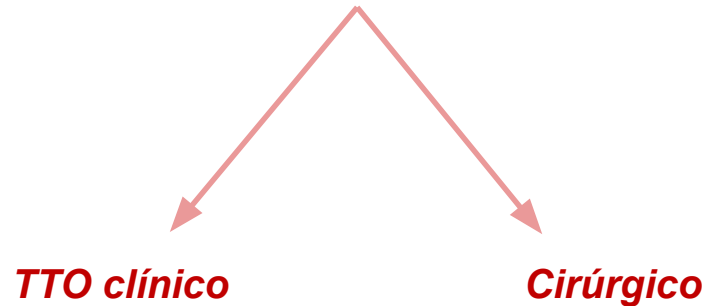
Volvo



Obstrução intestinal por aderências



- Representa 50% das LE de urgência
- Diagnóstico : TC contraste oral



Obstrução intestinal por aderências



- Representa 50% das LE de urgência
- Diagnóstico : TC contraste oral
- Contraste hidrossolúvel



Contraste Hidrossolúvel

- Diferente do bário: não causa peritonite química grave em caso de perfuração → mais seguro em obstrução.



Contraste Hidrossolúvel

- Diferente do bário: não causa peritonite química grave em caso de perfuração → mais seguro em obstrução.

Diagnóstico

Após administração, faz rastreamento radiológico (RX seriado ou TC):

- Se o contraste chega ao cólon em até 24h → alto valor preditivo de resolução espontânea.
- Se não progride → maior chance de necessidade cirúrgica.



Contraste Hidrossolúvel

- Diferente do bário: não causa peritonite química grave em caso de perfuração → mais seguro em obstrução.



Diagnóstico

Após administração, faz rastreamento radiológico (RX seriado ou TC):

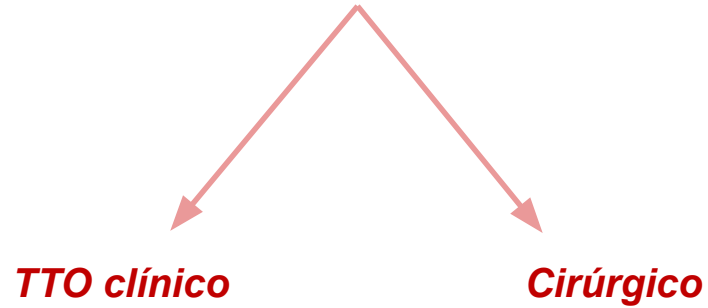
- Se o contraste chega ao cólon em até 24h → alto valor preditivo de resolução espontânea.
- Se não progride → maior chance de necessidade cirúrgica.

Tratamento

- Pelo seu efeito osmótico, atrai água para o lúmen intestinal → reduz edema de alça e estimula peristaltismo.
- Assim pode facilitar a resolução da obstrução sem cirurgia.



Obstrução intestinal por aderências



Obstrução intestinal por aderências

TTO clínico

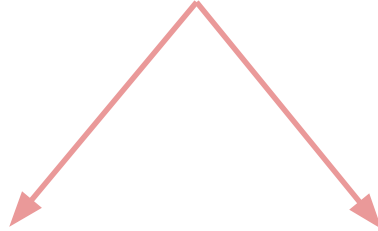
Cirúrgico

- Jejum
- Sonda nasogástrica
- Hidratação e eletrólitos
- 70-90% resolve

Até 72 hrs



Obstrução intestinal por aderências



TTO clínico

- Jejum
- Sonda nasogástrica
- Hidratação e eletrólitos
- 70-90% resolve

Cirúrgico

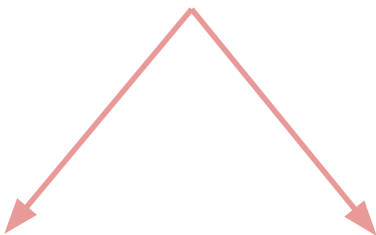
Se:

Perfuração ou sofrimento de alça

*VLP ou LE a critério cirurgião



Obstrução intestinal por aderências



TTO clínico

- Jejum
- Sonda nasogástrica
- Hidratação e eletrólitos
- 70-90% resolve

Cirúrgico

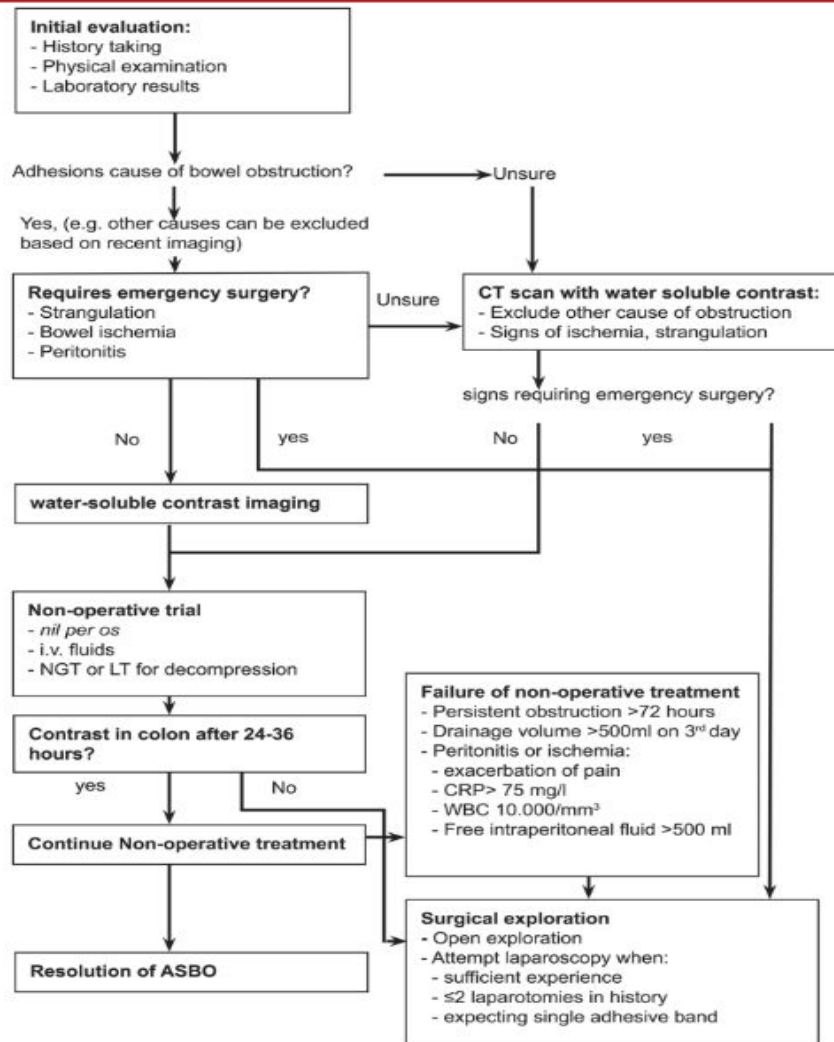
Se :

Perfuração ou sofrimento de alça

*VLP ou LE a critério cirurgião

Sem evidência para nutrição parenteral precoce





Volvos

Torção de uma alça do intestino sobre si mesma, com consequente obstrução do trânsito e potencial sofrimento / isquemia de alças.



Volvos

Torção de uma alça do intestino sobre si mesma, com consequente obstrução do trânsito e potencial sofrimento / isquemia de alças.

Otimização clínica

Descompressão EDA

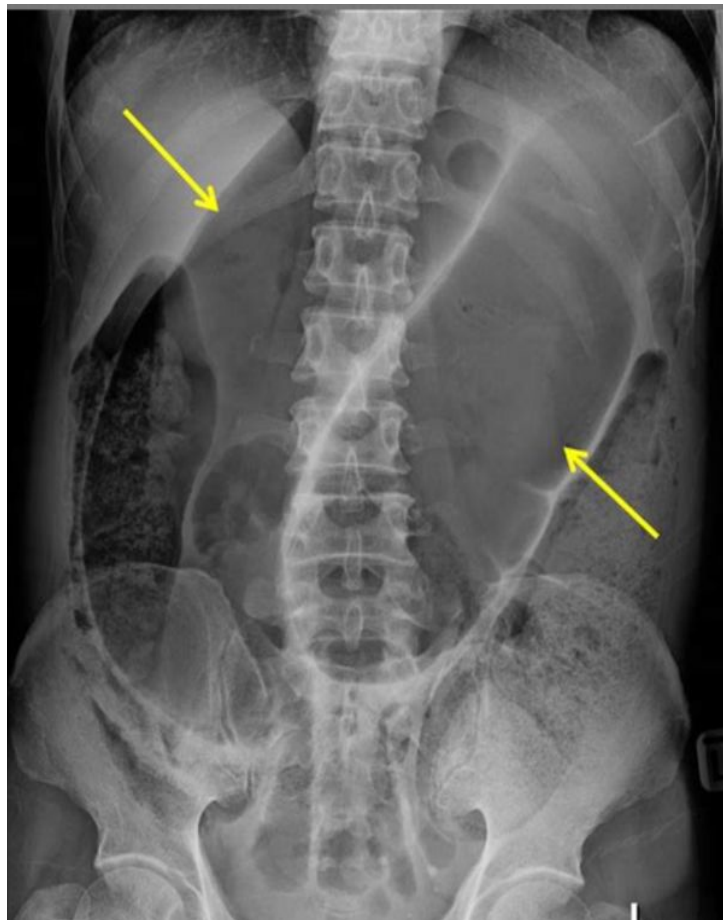
Cirurgia



Volvos

Aspecto	Sigmoide	Ceco
Epidemiologia	Mais comum em idosos, acamados, distúrbios neurológicos, constipação crônica	Mais raro; jovens ou adultos de meia-idade; pode associar-se a malrotação
Conduta inicial	Descompressão endoscópica (sucesso 60–90%), seguida de descompressão com sonda retal	Endoscopia pouco eficaz → geralmente não indicada
Risco de recorrência	Alto (>50% em alguns estudos)	Recorrência quase inevitável se não operado
Cirurgia definitiva	Sigmoidectomia eletiva após 1º episódio, ou urgência se recorrência/isquemia	Cirurgia imediata é recomendada (colectomia segmentar ou hemicolectomia direita)





Sigmóide



Ceco

Volvos

UTI

- Otimização clínica (hidratação, eletrólitos);
- Monitorizar sinais de complicações : peritonite;
- Antibióticos só se peritonite ou translocação confirmada;
- Acompanhar de perto o procedimento (colono descompressiva).



Obrigada

Dúvidas :

gastrointensiva@gmail.com

